

Agitación psicomotriz

F. J. Montero Pérez, L. Jiménez Murillo, T. Molina Nieto y M. Martínez Grueiro

CONCEPTO

La *agitación psicomotriz* es un síntoma, no una enfermedad, que se presenta en un 3% de los pacientes que consultan a un servicio de urgencias, y que requiere una asistencia inmediata. La mayoría de casos están relacionados con el consumo de alcohol. Es un fenómeno clínico que cursa con un estado mental alterado provocado por causas orgánicas (shock, alteraciones iónicas, intoxicación o abstinencia por alcohol y otras drogas de abuso, procesos neurológicos, etc.), o bien por agudizaciones de trastornos psiquiátricos, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia.

El síndrome confusional agudo o *delirium* (DL) es una de las posibles causas de agitación psicomotriz, aunque no siempre cursa con agitación. El DL es debido a causas somáticas, de inicio agudo o subagudo, acontece con frecuencia en personas de edad avanzada, sin antecedentes psiquiátricos. De evolución fluctuante, cursa con estado de alerta alterado, alteración del pensamiento (fluidez, claridad y coherencia), alteración de la atención (incapacidad para mantener la atención), desorientación temporoespacial, deterioro cognitivo, interrupción del ciclo sueño-vigilia y la presencia de signos físicos como taquicardia, taquipnea, sudoración, fiebre, etc. También puede haber alucinaciones visuales e ideación delirante. Por tanto, el DL es debido siempre a procesos orgánicos, difíciles de diferenciar de procesos psiquiátricos en ocasiones, lo que constituye un reto fundamental para el médico de urgencias.

La agitación psicomotriz representa un grave problema, tanto asistencial como social, en los servicios de urgencias, frecuentemente inadaptados para este tipo de pacientes que comportan un grave peligro para ellos mismos, sus familiares, el personal sanitario y el entorno. Por ello, deberían contar con un área específica, con las medidas de seguridad adecuadas, para tratar a este tipo de pacientes.

ETIOLOGÍA

La agitación psicomotriz puede ser de origen orgánico o somático (síndrome confusional agudo o *delirium*), por intoxicación aguda o abstinencia a drogas o sustancias de abuso o debida a un trastorno psiquiátrico primario. Las causas más frecuentes de cada uno de estos tipos de agitación psicomotriz se exponen en el [cuadro 69.1](#).

ACTITUD DIAGNÓSTICA

DESESCALADA VERBAL

En primer lugar, hay que adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar situaciones de peligro para el enfermo, los familiares y el personal del servicio de urgencias. Debe solicitarse ayuda al personal de seguridad del centro, celadores, etc.

Para abordar al paciente agitado, en primer lugar, hay que ofrecer al paciente una desescalada verbal siempre y cuando el paciente esté en condiciones de ser receptivo. Es la primera línea de actuación antes de tener que recurrir a la contención, y en ocasiones evita esta.

CONTENCIÓN

La contención es el procedimiento para controlar la alteración conductual y limitar la movilidad física del paciente. Puede ser: física (utilizando dispositivos mecánicos de sujeción) o farmacológica.

Para prevenir, y por tanto evitar, las consecuencias lesivas de la agresividad del paciente, tanto con él mismo (autoagresividad) como con el entorno o las personas que le rodean (heteroagresividad), el médico de urgencias debe conocer e investigar en el enfermo los factores que la favorecen ([cuadro 69.2](#)).

HISTORIA CLÍNICA

La anamnesis y la exploración física deben ir encaminadas a investigar los síntomas y signos que sugieran el origen orgánico o psíquico de la agitación psicomotriz. En este sentido, es muy importante la información facilitada por los acompañantes o familiares sobre los antecedentes somáticos y psiquiátricos del paciente, la forma de inicio, las características y la duración del episodio actual, así como la ingestión o la supresión de fármacos, consumo de drogas o tóxicos y retirada brusca de estos, antecedentes de traumatismo, aparición de fiebre, disnea, cefalea intensa, crisis convulsivas u otros síntomas somáticos. Asimismo, la exploración física debe ser completa y con especial atención en la búsqueda de desorientación, dificultad para el lenguaje, incoordinación motora, pérdida de memoria, paresias, debilidad/rigidez muscular, alteraciones de las constantes vitales y otros signos de inestabilidad hemodinámica, que denoten una causa orgánica de la agitación.

- **Agitación psicomotriz de origen orgánico.** Es una forma de presentación del denominado *síndrome*

CUADRO 69.1 Causas frecuentes de agitación**CAUSAS SOMÁTICAS U ORGÁNICAS (SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO O DELIRIUM)****Metabólicas**

Insuficiencia respiratoria (hipoxia o hipercapnia).
 Deshidratación.
 Hipo/hiperglucemia.
 Trastornos iónicos (sodio, calcio, magnesio).
 Fiebre/hipertermia.
 Insuficiencia cardíaca.
 Encefalopatías hepática y urémica.
 Acidosis metabólica.
 Porfiria aguda intermitente.

Endocrinológicas

Hipertiroidismo/hipotiroidismo.
 Insuficiencia suprarrenal aguda.
 Síndrome de Cushing.
 Hipoglucemia.
 Hiperglucemia.

Uso prolongado de fármacos

Neurolepticos.
 Antidepresivos.
 Antiepilepticos.
 Antiparkinsonianos.
 Antihistamínicos.
 Anticolinérgicos.
 Ansiolíticos.
 Opioides.
 Antibióticos.
 Esteroides.
 Inmunosupresores.
 Síndromes provocados por psicofármacos: síndrome neuroléptico maligno, síndrome serotoninérgico.
 Intoxicación digitalica.

Neurológicas

Encefalopatía hipóxico-isquémica.
 Meningoencefalitis.
 Traumatismo craneoencefálico moderado o grave.
 Epilepsia parcial compleja y estados poscríticos.

Hemorragia subaracnoidea espontánea.

Delirium superpuesto a demencia.

Neoplasias del sistema nervioso central.

Encefalopatía hipertensiva.

Accidente cerebrovascular/síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.

Otras

Fases iniciales del *shock* y fracaso multiorgánico.
 Sepsis.
 Retención aguda de orina.
 Dolor.

INTOXICACIÓN AGUDA/SÍNDROME DE ABSTINENCIA POR SUSTANCIAS DE ABUSO

Alcohol, cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, éxtasis, inhalantes, ketamina, LSD, cannabis, anticolinérgicos, neurolepticos, antidepresivos, benzodiazepinas.

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO PRIMARIO**Psicóticas**

Esquizofrenia.
 Trastornos esquizoafectivos.
 Episodio maniaco.
 Episodio depresivo (depresión agitada, frecuente en ancianos).
 Psicosis reactiva.
 Trastorno de ideas delirantes persistentes.

No psicóticas

Trastorno de ansiedad generalizado (crisis de ansiedad).
 Trastorno conversivo, disociativo.
 Trastorno de la personalidad (histriónico, límite, paranoide).
 Trastorno del espectro autista.
 Retraso mental con alteración de conducta.

Reactivas o situacionales (trastornos adaptativos)

Reacción de estrés agudo: accidentes, muerte de familiares (reacción de duelo).
 Privación sensorial.
 Pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos.
 Tras intervenciones oftalmológicas.

Conductas delictivas

confusional agudo o *delirium*, trastorno típicamente fluctuante de la atención y del contenido de la conciencia, al que se suman, de manera variable, alteraciones afectivas y emocionales, del pensamiento, del lenguaje, de la sensorpercepción, del juicio, del comportamiento psicomotor y del ciclo vigilia-sueño. Afecta al 20-25% de los pacientes hospitalizados, su incidencia aumenta con la edad y tiene una alta morbilidad. Fisiopatológicamente implica la existencia de una disfunción cerebral bilateral y difusa, lesiones críticas en el sistema reticular activador ascendente o, más raramente, lesiones focales en los lóbulos frontal o parietal derechos. En muchos casos, el sustrato bioquímico es una alteración del equilibrio de los neurotransmisores. A pesar de que las causas de este síndrome son muy numerosas (v. [cuadro 69.1](#)), un enfoque práctico supone valorar, por un lado, la existencia de circunstancias predisponentes o factores de riesgo, y por otro, los factores desencadenantes:

- **Factores predisponentes:** edad avanzada, trastornos visuales o auditivos, inmovilidad, enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson), demencia vascular o infartos cerebrales previos, abuso de sustancias, polimedicación, enfermedades sistémicas crónicas (insuficiencia cardíaca, renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica), etc.
- **Factores desencadenantes:** suelen ser situaciones de enfermedad aguda o por tóxicos. Entre los procesos agudos figuran los **neurológicos** (accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, crisis epilépticas, meningoencefalitis, etc.) y los **sistémicos** (deshidratación, infecciones, trastornos del sueño, problemas cardíacos, pulmonares, renales o hepáticos, cirugía cardíaca u ortopédica). Los **fármacos** desencadenantes de *delirium* son aquellos que tienen efecto directo sobre el sistema nervioso central, como opiáceos, antihistamínicos, anticolinérgicos, benzodiazepinas, antidepresivos, inmunosupresores, etc.

CUADRO 69.2 Factores que predisponen a la conducta violenta**AUTOAGRESIVIDAD**

Sexo masculino.
 Edad > 55 años.
 Estado civil: soltero o viudo.
 Desempleo o aislamiento sociofamiliar.
 Conductas suicidas previas o antecedentes familiares de suicidio.
 Enfermedad orgánica grave, crónica o dolorosa de base.
 Trastornos psicóticos (delirios, alucinaciones auditivas).
 Trastorno depresivo (ideas de culpa, nihilismo).
 Trastorno de personalidad (*borderline*).
 Trastorno de adaptación (acontecimientos vitales recientes).
 Trastornos mentales y del comportamiento por consumo de psicotrópicos.

HETEROAGRESIVIDAD

Sexo masculino.
 Edad 15-30 años.
 Bajo nivel socioeconómico.
 Ausencia de vínculos.
 Antecedentes violentos anteriores.
 Delirio de origen orgánico o tóxico.
 Trastornos paranoides.
 Trastornos psicóticos con alucinaciones auditivas.
 Trastornos maníacos.
 Trastornos de personalidad (*borderline*, disocial).

– En el proceso diagnóstico debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el síndrome confusional agudo sea la única manifestación aparente –sobre todo en ancianos y en pacientes crónicos debilitados– de diversas urgencias médicas ocultas: infarto agudo de miocardio, pielonefritis, insuficiencia respiratoria, etc.

– Los **datos clínicos** que sugieren una agitación de causa somática se detallan en el [cuadro 69.3](#). Hay que tener en cuenta que existen dos subtipos de síndrome confusional agudo: uno hiperactivo, fácilmente identificable, y otro hipoactivo (más frecuente cuanto mayor es la edad del paciente), que puede pasar desapercibido o confundirse con un trastorno depresivo si no se tienen en cuenta otros datos, como la alteración del ritmo circadiano, etc.

- **Agitación psicomotriz de origen psiquiátrico o reactivo.** No suele haber alteración del estado de conciencia ni de la atención. El paciente está vigil y orientado, aunque puede tener una pérdida grave del contacto con la realidad, delirio y alucinaciones si la agitación es psicótica. Los datos clínicos que sugieren un origen psíquico se exponen en el [cuadro 69.4](#).

El error más grave que puede cometerse ante un paciente agitado es presumir un origen psiquiátrico, olvidando descartar un proceso orgánico, potencialmente vital, como la hipoglucemia, la hemorragia subaracnoidea, la intoxicación aguda grave, la meningoencefalitis, el hematoma subdural o epidural, la encefalopatía de Wernicke, etc. Especial atención merecen las encefalitis autoinmunitarias (la que cursa con anticuerpos anti-NMDA es el prototipo), cada vez con

CUADRO 69.3 Datos clínicos indicativos de síndrome confusional agudo

Ausencia de antecedentes psiquiátricos.
 Comienzo agudo o hiperagudo (súbito, minutos u horas).
 Curso fluctuante.
 Ausencia de episodios similares anteriores.
 Antecedentes de enfermedad orgánica: endocrinometabólica, renal, cardíaca, neurológica, respiratoria y hepática.
 Antecedentes y estigmas de abuso de drogas (pacientes jóvenes).
 Interrupción brusca del consumo de fármacos o tóxicos.
 Edad avanzada.
 Alteración del estado de conciencia.
 Desorientación temporoespacial.
 Lenguaje incoherente.
 Alucinaciones visuales y táctiles.
 Alteraciones psicóticas desorganizadas.
 Alteración de la memoria reciente.
 Focalidad neurológica: afasia, déficits motores o sensitivos, rigidez de nuca y otros signos meníngeos.
 Alteraciones neurovegetativas: hipertensión, taquicardia, midriasis, diaforesis.
 Signos autonómicos.

CUADRO 69.4 Datos clínicos indicativos de agitación de origen psiquiátrico

Antecedentes personales o familiares de psicopatías.
 Antecedentes de episodios similares anteriores.
 Ausencia de alteración del estado de conciencia y de la atención.
 Ausencia de semiología neurológica.
 Alucinaciones auditivas.
 Semiología típica de la causa de la agitación:
 Maníaca: euforia, verborrea y grandiosidad.
 Neurótica: reactividad al ambiente con participación activa en el agravamiento o en la catarsis de la crisis. Suele haber beneficio secundario y búsqueda de algún objetivo concreto.
 Delirante: interacción inapropiada, delirios y alucinaciones.

mayor incidencia, que pueden presentarse clínicamente como un brote psicótico agudo.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

A la llegada del paciente a urgencias se determina, en primer lugar, la glucemia mediante tira reactiva para descartar una hipoglucemia sintomática. A continuación, se cursan con carácter urgente las siguientes exploraciones:

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** La leucocitosis con desviación a la izquierda orienta hacia un proceso infeccioso.
- **Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, creatina cinasa (CK), CK-MB, troponina, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y bilirrubina total y directa. Pueden encontrarse alteraciones que sugieran una alteración endocrino-metabólica, renal, cardíaca o hepática, como causante del cuadro de agitación.
- **Gasometría arterial.** Permite comprobar el equilibrio acidobásico y la función respiratoria.

- **Orina completa con sedimento** para descartar, en la medida de lo posible, una infección urinaria.
- **Radiografías posteroanterior y lateral de tórax.** Las infecciones respiratorias pueden cursar con escasos síntomas generales, con predominio de los cambios del estado mental del paciente.
- **Electrocardiograma,** para objetivar o descartar alteraciones del ritmo o cardiopatía isquémica.
- **Cuantificación de tóxicos o drogas en sangre y orina,** si hay sospecha clínica de intoxicación.

La realización de otras exploraciones complementarias depende de la sospecha diagnóstica:

- **Estudio de coagulación y amoniemia:** encefalopatía hepática.
- **Tomografía computarizada (TC) craneal:** traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular, meningoencefalitis.
- **Punción lumbar:** meningitis o hemorragia subaracnoidea no detectada en la TC.

CRITERIOS DE INGRESO

La necesidad de ingreso hospitalario se define por la causa de la agitación. Con carácter general, los pacientes con agitación de causa orgánica o psiquiátrica requieren ingreso, mientras que los de causa reactiva o situacional pueden recibir el alta con tratamiento ansiolítico.

ACTITUD TERAPÉUTICA

MEDIDAS GENERALES

Medidas de seguridad

En presencia de armas u objetos peligrosos, el personal sanitario debe retirarse momentáneamente para que actúe el personal de seguridad o las fuerzas de seguridad del Estado, desarmando al paciente si fuera portador de armas. Hay que tener presente que el paciente agitado es un problema clínico, por lo que los profesionales sanitarios no deben inhibirse y tomar la iniciativa una vez conseguida la reducción del paciente. Se debe retirar a los acompañantes conflictivos.

Desescalada verbal ofreciendo información

En primer lugar, se realiza una desescalada verbal, si el paciente es receptivo a ella. Se debe aparentar calma, controlar la situación, escuchar al enfermo, evitar el contacto visual directo intenso o prolongado (para evitar que sea percibido como amenazante), no utilizar lenguaje beligerante, minimizar los tiempos de espera, tratar al paciente con respeto y empatía y reducir los estímulos externos (luz, ruidos intensos), que exacerben la agitación del paciente. Todas estas son las claves de la desescalada verbal. Esta técnica no es suficiente o es inefectiva en el paciente con agitación de causa orgánica.

Adecuación del entorno

Se debe ubicar al paciente en una consulta con mobiliario simple y fijo. Retirar los objetos potencialmente utilizables como armas. La consulta debe contar con una segunda

salida («de escape»). Mantener la distancia de seguridad óptima con el paciente.

Medidas psicológicas de ayuda

- Evitar precipitarse instaurando un tratamiento sintomático.
- Identificarse como personal sanitario.
- Ofrecer alimento y bebida.
- Mostrar una actitud tranquilizadora, pero de firmeza.
- Hablar suavemente y con preguntas cortas.
- No enfrentarse con el enfermo, aunque es importante limitar su conducta, comunicándole cuál es aceptable y cuál no.
- No mostrar cólera ni amenazar.
- La presencia de un familiar o la estimulación continuada pueden bastar para controlar a ciertos enfermos agitados.
- No dejar nunca al paciente solo, incluso cuando esté inmovilizado.
- Valorar si hay que adoptar otras medidas, además de las psicológicas y ambientales.

CONTENCIÓN FÍSICA

La contención física es efectiva y ética cuando facilite el diagnóstico y el tratamiento del paciente, y prevenga lesiones, tanto a él como a los que le rodean. Antes de proceder a la contención debe informarse al paciente de por qué tiene que llevarse a cabo, y cuáles son las opciones terapéuticas, ofreciéndole siempre, en primer lugar, el tratamiento farmacológico. En ocasiones, la sola presencia y la disposición del personal para la contención hacen que el paciente reconozca como real su inminencia, y motivan un cambio de actitud y su cooperación espontánea, que evitan la necesidad de contención física.

La sujeción física se utiliza cuando no se pueden poner en práctica las técnicas de desescalada verbal por parte del profesional sanitario ni administrar el tratamiento farmacológico. Debe haber suficiente personal sanitario (seis personas) con la formación y la experiencia necesarias. Una para cada extremidad, otra para la cabeza y otra para aplicar el dispositivo de contención. En cuanto se ha obtenido el control físico del paciente, se debe administrar la primera dosis del fármaco elegido (ver más adelante).

Procedimiento

El médico responsable del paciente dirige el procedimiento y, a la vez, sujeta y protege la cabeza del paciente, mientras cuatro personas sujetan cada uno de los miembros del enfermo. La posición de contención ideal es la de decúbito supino, con la cabecera elevada, para permitir al enfermo mantener contacto visual con el medio y disminuir el riesgo de aspiración. Las piernas deben estar abiertas y los brazos en abducción de 30°, que permita la canalización de la vía venosa. La contención física debe ir siempre acompañada de tratamiento farmacológico que ayude a controlar al paciente.

La suspensión de la inmovilización física debe ser progresiva, observando la respuesta del paciente. Se retira la sujeción de un solo miembro cada vez, a intervalos de 5 min, excepto los dos últimos, que se retiran simultáneamente. No debe dejarse nunca a un paciente sujeto por un solo miembro porque, además de poder soltarse, podría autolesionarse.

La contención física está contraindicada en el paciente hemodinámicamente inestable, que requiere monitorización. Asimismo, debe evitarse si el paciente ha tenido un intento de suicidio y, sobre todo, en el paciente con intoxicación aguda, especialmente por drogas simpaticomiméticas (anfetaminas, cocaína, etc.), ya que la contención física puede favorecer la aparición de arritmias cardíacas, agravar la rabdomiólisis e incluso provocar la muerte súbita. Nunca debería utilizarse la posición prona con las manos atadas a la espalda, técnica de contención utilizada frecuentemente por la policía y las fuerzas de seguridad, ya que favorece la asfixia del paciente agitado.

La contención y la sujeción física son medidas muy estresantes para el paciente, por lo que debe ir siempre complementada con una eficaz sedación farmacológica, más o menos intensa según el grado de agitación del paciente y la causa del cuadro, hasta que se logre controlar el estado de agitación. Si se mantiene más de 24 h es necesario administrar profilaxis de la enfermedad tromboembólica mediante heparina de bajo peso molecular.

CONTENCIÓN FARMACOLÓGICA

Selección del fármaco y la vía de administración

La elección del tipo de fármaco que se va a utilizar y la vía de administración dependen del grado de agitación, de que el paciente colabore o no colabore, y de la sospecha diagnóstica.

Como normas generales, se prefiere la monoterapia y, si es posible, vías no invasivas, como la vía oral, sublingual, bucodispersable o inhalatoria (si el paciente colabora). De no ser el paciente colaborador se recurre a la vía parenteral, bien intramuscular o intravenosa.

- Si el paciente no presenta síntomas psicóticos, los fármacos de elección son las benzodiacepinas; si, por el contrario, presenta estos síntomas, se administran neurolépticos. En el delirio alcohólico se prefieren las benzodiacepinas. En los casos leves-moderados pueden ser suficientes en monoterapia; sin embargo, es preferible la combinación de ambos grupos de fármacos (midazolam o lorazepam, y haloperidol), por las razones que a continuación se exponen.
- La vía de administración elegida en los pacientes que necesiten una sedación rápida y eficaz es la intravenosa, si bien en la actualidad se ha demostrado una buena absorción por vía intramuscular de dos benzodiacepinas (lorazepam y midazolam), aunque de estas solo el midazolam está disponible en nuestro país para uso parenteral.
- Es recomendable utilizar dosis bajas y acortar en lo posible la duración del tratamiento, ya que estos fármacos pueden contribuir a perpetuar el síndrome confusional, aunque temporalmente mejoren los síntomas.

Grupos terapéuticos

Benzodiacepinas

Están indicadas fundamentalmente en pacientes agitados por abstinencia de alcohol, benzodiacepinas o barbitúricos; intoxicación aguda por cocaína, anfetaminas o fenciclidina;

en la agitación posterior a una crisis comicial; y cuando se requiera una sedación rápida para la realización de exploraciones diagnósticas (TC, punción lumbar, etc.). Hay que tener en cuenta que, si la agitación es de mecanismo incierto, estos fármacos pueden producir un aumento paradójico de los síntomas, así como sedación, depresión respiratoria, ataxia y amnesia, hecho especialmente relevante en los casos de tratamiento prolongado con fármacos de vida media larga, como el diazepam. Se deben utilizar benzodiacepinas de inicio de acción rápido y vida media corta.

Las benzodiacepinas más utilizadas son las siguientes:

- **Midazolam** (ampollas de 5 mL con 5 mg y de 3 mL con 15 mg). Se administra por vía intravenosa en dosis inicial de 0,1 mg/kg, para lo que se diluye una ampolla de la presentación de 15 mg en 12 mL de solución salina fisiológica (1 mL contiene 1 mg), y se infunden en bolo intravenoso lento, 7 mL para un paciente de 70 kg. Si se elige la presentación de 5 mL con 5 mg, se administran 7 mL sin necesidad de dilución. Si fuese necesario, puede repetirse la dosis, sin sobrepasar la dosis total de 0,4 mg/kg de peso. Cuando no sea posible el abordaje intravenoso, se administra por vía intramuscular en dosis de 0,2 mg/kg (1 ampolla de 15 mg, aproximadamente), con lo que se obtiene la respuesta en unos 6 min. También puede administrarse por vía intranasal.
- **Diazepam** (ampollas de 2 mL con 10 mg) en dosis de 10 mg (1 ampolla) por vía intravenosa lenta. Para ello, se diluye 1 ampolla en 8 mL de solución salina fisiológica, y se infunde a un ritmo de 1 mg/min (1 mL/min). Del adecuado ritmo de administración dependerá que no aparezcan complicaciones como la depresión respiratoria.
- **Lorazepam** (comprimidos de 1 mg) en dosis de 1-2 mg por vía oral o sublingual.
- **Clorazepato dipotásico** (viales con 20 y 50 mg) en dosis de 50 mg por vía intramuscular.

Neurolépticos

Los antipsicóticos están siempre indicados, independientemente del subtipo motor, ya que mejoran la función cognitiva, los síntomas psicóticos y la conducta motora aberrante, y facilitan la normalización del ciclo sueño-vigilia. La vía de elección es la intravenosa, ya que es más rápida y no aumenta el riesgo de que se produzcan efectos secundarios si se administran adecuadamente. La prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma es un efecto conocido de muchos neurolépticos (QT corregido > 500 ms aumenta el riesgo de *torsades de pointes*), por lo que durante su administración debe realizarse monitorización electrocardiográfica. Los efectos extrapiramidales de los neurolépticos clásicos o de primera generación son también conocidos.

En el paciente anciano deben evitarse los neurolépticos de primera generación frente a los de segunda generación. De estos últimos, olanzapina y risperidona incrementan la mortalidad en la psicosis relacionada con la demencia, por lo que deben igualmente evitarse en estos casos.

Además, en pacientes ancianos deben utilizarse en dosis más bajas que en el paciente no anciano. Comenzar por la mitad de dosis, por ejemplo.

Los fármacos más utilizados son los siguientes:

- **Haloperidol** (ampollas con 5 mg). Es el neuroléptico de elección, ya que tiene una gran potencia antipsicótica y menos efectos anticolinérgicos e hipotensión ortostática. Su inicio de acción se produce a los 30-45 min. La dosis media inicial es de 5 mg por vía intravenosa, que puede repetirse cada 30 min hasta conseguir la sedación, la aparición de efectos secundarios o alcanzar la dosis máxima de 50 mg en 24 h. En pacientes mayores y en los casos hipoactivos es prudente comenzar con dosis más bajas (p. ej., 1 mg/12 h), e incrementarla progresivamente si es necesario. Los pacientes jóvenes o muy agitados pueden necesitar, inicialmente, hasta 10 mg/2 h.
- **Clorpromazina** (ampollas con 25 mg) en dosis de 25 mg por vía intramuscular o intravenosa, diluyendo en este caso 1 ampolla en 100 mL de solución salina fisiológica, y se infunden en 20-30 min (nunca debe administrarse en bolo intravenoso). Esta dosis puede repetirse cada 2-4 h hasta conseguir la sedación, la aparición de efectos secundarios (hipotensión ortostática, hipotensión grave y depresión respiratoria) o hasta alcanzar una dosis máxima de 25-50 mg/6-8 h. Tiene una acción sedante mayor que el haloperidol, pero disminuye el umbral convulsivo.
- **Levomepromazina** (ampollas con 25 mg) es el neuroléptico de mayor acción sedante. Se utiliza en dosis de 25-50 mg por vía intramuscular (nunca intravenosa), que puede repetirse cada 2-4 h hasta conseguir la sedación, sin sobrepasar la dosis máxima diaria de 200 mg.
- **Antipsicóticos atípicos (o de segunda generación)**. Tienen una acción antiserotoninérgica y menor acción antidopaminérgica, por lo que presentan menos efectos secundarios extrapiramidales, menor riesgo de prolongación del intervalo QT (olanzapina y quetiapina) y menor sedación. Pueden ser de elección cuando se desee disminuir estos efectos, siempre y cuando la vía oral sea suficiente y adecuada. Sin embargo, la menor experiencia de uso y las restricciones para su prescripción, sujeta a visado, hacen que sean la segunda opción terapéutica, excepto la quetiapina en los pacientes con síndromes parkinsonianos o demencia con cuerpos de Lewy, que es la primera opción al estar contraindicados los antipsicóticos clásicos. Se dispone de:
 - **Risperidona** (comprimidos de 0,5, 1, 2, 3, 4 y 6 mg) en dosis inicial de 1-2 mg, seguida de 0,5-1 mg/24 h por vía oral (dosis máxima: 6 mg/24 h). Su inicio de acción se produce entre los 30-60 min.
 - **Olanzapina** (comprimidos de 2,5, 5, 7,5 y 10 mg; viales con 10 mg; comprimidos bucodispersables de 5, 10, 15 y 20 mg) en dosis inicial de 5-10 mg, seguida de 10-20 mg/24 h. Su inicio de acción se produce entre los 15-45 min. Es particularmente efectiva para controlar la agitación en el paciente con esquizofrenia o manía bipolar.

- **Quetiapina** (comprimidos de 25, 100, 200 y 300 mg) en dosis inicial de 100 mg, seguida de una dosis de mantenimiento de 100-200 mg/12 h.
- **Ziprasidona** (cápsulas de 20, 40, 60 y 80 mg; vial inyectable de 1 mL con 20 mg): 10-20 mg por vía oral o intramuscular. Por esta última vía el inicio de acción se produce a los 15-30 min de su administración y su vida media es tan solo de 2,5 h. Se puede administrar una dosis de 10 mg cada 2 h (dosis máxima total: 40 mg/día). No se recomienda la vía intramuscular en pacientes mayores de 65 años. Este fármaco puede causar prolongación del espacio QT.

Combinaciones de fármacos

La combinación racional de benzodiacepinas y neurolépticos puede ser más eficaz que cada fármaco por separado en casos de agitación intensa, si bien la probabilidad de aparición de efectos secundarios es mayor. La pauta de administración más utilizada es la siguiente:

- Benzodiacepinas: lorazepam (comprimidos de 1 mg) en dosis de 2 mg por vía oral o sublingual; o midazolam (ampollas de 5 mL con 5 mg y de 3 mL con 15 mg) en dosis de 7 mg por vía intravenosa (7 mL de la dilución de 1 ampolla de 15 mg en 12 mL de solución salina fisiológica o 7 mL de la presentación de 5 mg sin diluir) o en dosis de 15 mg (1 ampolla de 15 mg) por vía intramuscular. Uno u otro combinado con haloperidol (ampollas con 5 mg) en dosis de 5 mg por vía intravenosa o intramuscular.
- O bien olanzapina más midazolam en las dosis ya referidas de estos fármacos.

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

La identificación precoz y el tratamiento de las causas predisponentes y desencadenantes son fundamentales para mejorar el pronóstico, acortar la estancia hospitalaria y disminuir o eliminar la necesidad de un tratamiento sedante agresivo. Para ello deben consultarse los capítulos correspondientes de este libro. Asimismo, deben establecerse las medidas necesarias para prevenir las complicaciones frecuentes en pacientes encamados o en dieta absoluta: heparina de bajo peso molecular para prevenir la trombosis venosa profunda, fluidoterapia, tiamina parenteral para la prevención de la encefalopatía de Wernicke, etc.

Bibliografía recomendada

- Garriga N, Pinzón JE, Solé E, et al. Agitación: evaluación y manejo. En: Glik RL, Zeller SL, Berlin JS, coordinadores. Urgencias psiquiátricas. Principios y práctica, 2.ª ed. L'Hospital de Llobregat: Wolters Kluwer; 2021. p. 190-202.
- Simpson SA, Salg LA. Agitación: desescalada. En: Glik RL, Zeller SL, Berlin JS, coordinadores. Urgencias psiquiátricas. Principios y práctica, 2.ª ed. L'Hospital de Llobregat: Wolters Kluwer; 2021. p. 183-9.